



VIA
Vida Integrada e
Autônoma

← Voltar ao
hub

SAÚDE PÚBLICA · COMUNICAÇÃO DE RISCO

Saúde na Última Semana

Boletim de **utilidade pública** da Iniciativa VIA. Traduzimos temas de vigilância e prevenção para o público geral — com o sarampo como caso de comunicação de risco — em linguagem clara, com escopo explícito e fontes oficiais.

EDIÇÃO DE 21 DE AGOSTO DE
2026

EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

BRASIL

O QUE ESTE BOLETIM É — E O QUE NÃO É

É material educativo para orientar decisões cotidianas de prevenção.

NÃO É

triagem, diagnóstico nem fonte de dados epidemiológicos ao vivo. Diante de sintomas, procure uma unidade de saúde; para números atualizados, consulte as fontes oficiais indicadas ao final.

NESTA EDIÇÃO

O que mudou na saúde nesta semana

ATUALIZADO EM 21 DE AGOSTO DE 2026

01 · EM FOCO

Sarampo nas Américas: o pior ano em duas décadas

02 · AGENDA

Multivacinação e o Dia D de 22 de agosto

03 · TRATAMENTOS

O que foi aprovado e o que vem por aí

04 · IA NA SAÚDE

A evidência econômica desmente a promessa

05 · PRÁTICA

O que fazer nesta semana

Revista editorial de utilidade pública, compilada de fontes oficiais e da literatura científica na data acima. Números mudam a cada semana — confira sempre a fonte antes de agir ou compartilhar.

01 · EM FOCO

Sarampo nas Américas: o maior número de casos em 22 anos

Em **7 de agosto**, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) emitiu alerta epidemiológico: a Região das Américas registra em 2026 o maior número de casos confirmados de sarampo dos últimos **22 anos**. A recomendação é fortalecer vacinação, vigilância e resposta rápida. No Brasil, o Ministério da Saúde reforçou o **bloqueio vacinal** diante de casos importados, com intensificação em **Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo**.

O QUE É

Um vírus de altíssima transmissão

Transmite-se pelo ar, por gotículas e aerossóis que permanecem suspensos por até cerca de duas horas em ambientes fechados.

- Uma pessoa não imunizada pode contagiar, em média, **12 a 18 outras** (R_0).
- O período de incubação costuma ser de **10 a 14 dias**.
- A pessoa transmite **antes mesmo** de a manifestação de pele aparecer.

SINAIS

Como o quadro costuma se apresentar

A combinação clássica é febre alta seguida de manchas na pele, acompanhada dos chamados “três C”.

- **Tosse, coriza e conjuntivite** (olhos vermelhos) com febre.
- Manchas vermelhas que surgem no rosto e **descem pelo corpo**.
- Sinais de alerta: falta de ar, sonolência importante, desidratação.

PREVENÇÃO

Duas doses resolvem

A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é **gratuita no SUS** e altamente eficaz.

- **Duas doses** conferem cerca de **97% de proteção**.
- No calendário infantil: 1ª dose aos 12 meses, 2ª aos 15 meses.
- Adultos sem comprovação devem verificar a caderneta na unidade de saúde.

POR QUE IMPORTA AGORA

Eliminação conquistada, atenção redobrada

O Brasil recuperou em 2024 o certificado de país livre da circulação do sarampo. Com o vírus em alta no continente, manter esse status depende de cobertura vacinal alta e constante.

- É preciso cerca de **95% de cobertura** para bloquear a circulação.
- Casos importados reacendem surtos onde há bolsões não vacinados.
- Prevenir é responsabilidade coletiva: protege quem não pode se vacinar.

QUEM CORRE MAIS RISCO

A vacinação protege os mais vulneráveis

As complicações são mais graves em grupos que dependem da imunidade coletiva — a chamada proteção de rebanho.

- Bebês com menos de 1 ano, ainda sem idade para a 1ª dose.
- Gestantes e pessoas com imunidade comprometida.
- Complicações possíveis: pneumonia, otite e, mais raramente, encefalite.
- Cada pessoa vacinada reduz a chance de o vírus chegar a esses grupos.

Quando procurar atendimento

Febre com manchas na pele, especialmente após contato com caso suspeito ou viagem, merece avaliação. Ligue antes para a unidade e evite exposição a outras pessoas no trajeto.

[Alerta do Ministério da Saúde ↗](#)

02 · AGENDA DE VACINAÇÃO

A campanha está aberta — e o Dia D é amanhã

Duas mudanças concretas no calendário nacional entram em vigor neste mês. Ambas são gratuitas no SUS e dependem apenas de levar a caderneta à unidade de saúde.

DIA D · 22 DE AGOSTO

Multivacinação 2026

Campanha nacional para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes **menores de 15 anos**. A mobilização segue até **1º de setembro**, com Dia D nacional em 22 de agosto.

DESDE 3 DE AGOSTO

Poliomielite: novo reforço aos 4 anos

O esquema contra a poliomielite passou a incluir um **segundo reforço da VIP** (vacina inativada) aos **4 anos de idade**.

O ANO TODO

Adultos também têm calendário

Tríplice viral, febre amarela, hepatite B, dT e gripe têm indicação para adultos. Quem não comprova doses de sarampo deve procurar a unidade.

Leve a caderneta — mesmo que esteja em dia

A conferência é rápida e gratuita. Doses atrasadas podem ser atualizadas na hora, sem necessidade de recomençar o esquema.

[Calendário nacional de vacinação ↗](#)

O que foi aprovado — e o que ainda é promessa

Registro do que saiu do laboratório e chegou à regulação neste ciclo. A distinção importa: **aprovação regulatória** não é o mesmo que disponibilidade no SUS, nem que indicação para todos os pacientes.

ANVISA • BRASIL

Novos registros e indicações ampliadas

A Resolução nº 2.831/2026, de 20 de julho, reúne decisões de registro e ampliação de indicações terapêuticas para **linfoma não Hodgkin, câncer renal, hemofilia, lúpus e esclerose múltipla**.

FDA • TERAPIA GÊNICA

Primeira terapia gênica para surdez genética

Aprovada a primeira terapia gênica destinada à **perda auditiva de origem genética** — marco para doenças sensoriais hereditárias.

ONCOLOGIA • CAR-T

CAR-T chega ao tumor sólido

A terapia **satri-cel** foi aprovada para adenocarcinoma gástrico ou da junção esofagogástrica: a primeira terapia com células CAR-T aprovada para um **tumor sólido**.

DIABETES • EM AVALIAÇÃO

Células-tronco no diabetes tipo 1

O **zimislecel** deve ser submetido às agências reguladoras: em estudos, uma injeção única levou casos específicos a dispensar insulina. Ainda **sem aprovação**.

BRASIL • PESQUISA NACIONAL

Vacina brasileira contra covid-19 avança

A **SpiN-TEC** (CTVacinas/UFMG, com apoio da Finep) deve entrar na última fase de estudos clínicos — a primeira vacina 100% desenvolvida no Brasil a chegar a essa etapa.

A evidência econômica não sustenta a promessa

Este é o eixo em que a VIA tem posição declarada: **complexidade precisa pagar aluguel**. Uma camada nova só se justifica quando reduz risco, trabalho ou ambiguidade de forma demonstrável. A literatura desta semana ajuda a separar ganho de retórica.

REVISÃO SISTEMÁTICA · HEALTH POLICY, 2026

Projeções de mercado falam em **US\$ 200-360 bilhões** de economia anual nos Estados Unidos e **€ 212 bilhões** na Europa. Uma revisão sistemática rastreou 16.430 registros acadêmicos e analisou **98 avaliações econômicas** de tecnologias de IA em saúde. Resultado: apenas **36% demonstram preferência econômica clara** pela IA — proporção que sobe para **44%** entre os 51 estudos de alta qualidade.

A conclusão dos autores é sóbria e vale como régua editorial: há potencial real de custo-efetividade, mas a evidência disponível **não sustenta** as projeções de centenas de bilhões em economia. As aplicações concentram-se em oftalmologia e oncologia, voltadas a prestadores de serviço.

Schmidt J, Carter AW, McGuire A, Mossialos E, van Kessel R. A systematic review of economic evidence of artificial intelligence in healthcare. Health Policy. 2026;172:105715. Recuperado do PubMed. DOI: [10.1016/j.healthpol.2026.105715](https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2026.105715) ↗

REVISÃO SISTEMÁTICA · NURSING IN CRITICAL CARE, 2026

Do lado clínico, o sinal é promissor e igualmente cauteloso. Em cuidados agudos e intensivos, sistemas de apoio à decisão com IA **operados por enfermeiros** associaram-se a menor mortalidade hospitalar (**RR 0,68; IC 95% 0,53-0,87**) em sete estudos com cerca de **75 mil pacientes**.

O próprio estudo qualifica o achado: o intervalo de predição **inclui a possibilidade de nenhum efeito**, os desfechos relatados por profissionais são escassos e a implementação exige atenção a carga de alertas, equidade e segurança. Ferramentas que **apoiam** o julgamento clínico — sem substituí-lo — são as que mostram benefício.

Almagharbeh WT, Alkubati SA, Alasmari AA, et al. Harnessing Artificial Intelligence to Strengthen Acute and Critical Care Nursing Practice: A Systematic Review. Nurs Crit Care. 2026;31(5):e70606. Recuperado do PubMed. DOI: [10.1111/nicc.70606](https://doi.org/10.1111/nicc.70606) ↗

Mais operação do que diagnóstico

A adoção de IA por estabelecimentos de saúde brasileiros avança, mas concentrada em tarefas **operacionais** — organização de processos clínicos e administrativos — mais do que em decisão diagnóstica.

O CFM chegou antes do marco legal

Antes da consolidação de um marco legal geral sobre inteligência artificial, o **Conselho Federal de Medicina** passou a disciplinar o uso da tecnologia na prática médica.

A decisão continua humana

O desafio declarado é garantir que a decisão médica siga sendo tomada por pessoas. A IA entra como **apoio técnico**, com supervisão e rastreabilidade — nunca como substituto do juízo clínico.

05 · AÇÃO PRÁTICA

O que fazer nesta semana

Cinco atitudes de baixo custo e alto retorno, ancoradas no que esta edição trouxe.



Aproveite o Dia D, em 22 de agosto

Leve a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos à unidade de saúde. A campanha segue até 1º de setembro.



Confirme as duas doses de tríplice viral

Com o sarampo em alta nas Américas, quem não comprova as duas doses deve procurar a unidade — inclusive adultos, antes de viajar.



Elimine água parada

Dez minutos por semana checando vasos, garrafas, calhas e caixas d'água cortam os criadouros do mosquito da dengue.



Cuide da etiqueta respiratória

Ventile ambientes, higienize as mãos e cubra tosse e espirro. Mantenha a vacina da gripe em dia.



Desconfie de promessa sem estudo

Vale para tratamento novo e para IA: pergunte qual estudo sustenta a alegação, com quantos pacientes e comparado a quê. Antes de compartilhar, confirme na fonte oficial.

TRANSPARÊNCIA

MÉTODO EDITORIAL

A fonte não é a ferramenta.

Cada edição é montada por varredura de fontes oficiais de saúde e da literatura científica indexada, com verificação de data e origem. Esta revista organiza e traduz; ela não gera dados. Números epidemiológicos mudam a cada semana e devem ser conferidos nas instituições responsáveis. Onde citamos ordens de grandeza consolidadas — como R_0 e eficácia vacinal —, elas explicam o mecanismo, não reportam a situação atual. Estudos científicos são citados com identificador digital (DOI) para verificação direta.

Ministério da Saúde

Alerta de sarampo, Multivacinação 2026 e calendário nacional



OPAS/OMS Brasil

Alerta epidemiológico de 7 de agosto sobre sarampo nas Américas



Anvisa

Resolução nº 2.831/2026 — registros e ampliação de indicações



PubMed

Base de literatura biomédica — revisões sistemáticas citadas nesta edição



Schmidt J, et al. Health Policy, 2026

Evidência econômica de IA em saúde — DOI 10.1016/j.healthpol.2026.105715



Almagharbeh WT, et al. Nurs Crit Care, 2026

IA em enfermagem de cuidados críticos — DOI 10.1111/nicc.70606



Fiocruz

Ciência, pesquisa e educação em saúde pública



VIA

Vida Integrada e Autônoma

Ciência e Tecnologia a serviço do Cuidado.

Conheça a Iniciativa VIA →

DIREÇÃO CLÍNICA

Dr Lucas HR

Médico Generalista (FMRP-USP)

CRM-SP: 226836 | CRM-MG: 109752

WhatsApp Business: +55 16 99618-0196

ESTE BOLETIM

Utilidade pública e educação em saúde.

Código e versões ↗

Conteúdo educativo, sem finalidade diagnóstica ou terapêutica. Não substitui a consulta com profissional de saúde nem os canais oficiais de vigilância. Diante de sinais de alerta, procure uma unidade de saúde ou o serviço de emergência.

[Substack ↗](#)[YouTube ↗](#)[Instagram ↗](#)[Medium ↗](#)[GitHub ↗](#)[Doctoralia ↗](#)[WhatsApp ↗](#)

Dr Lucas HR Almeida — Médico Generalista (FMRP-USP) · CRM-SP 226836 | CRM-MG 109752

Iniciativa VIA — Vida Integrada e Autônoma · Ciência e Tecnologia a serviço do Cuidado.

[Iniciativa VIA](#) · [Sobre o fundador](#)